

순천향대학교 천안병원

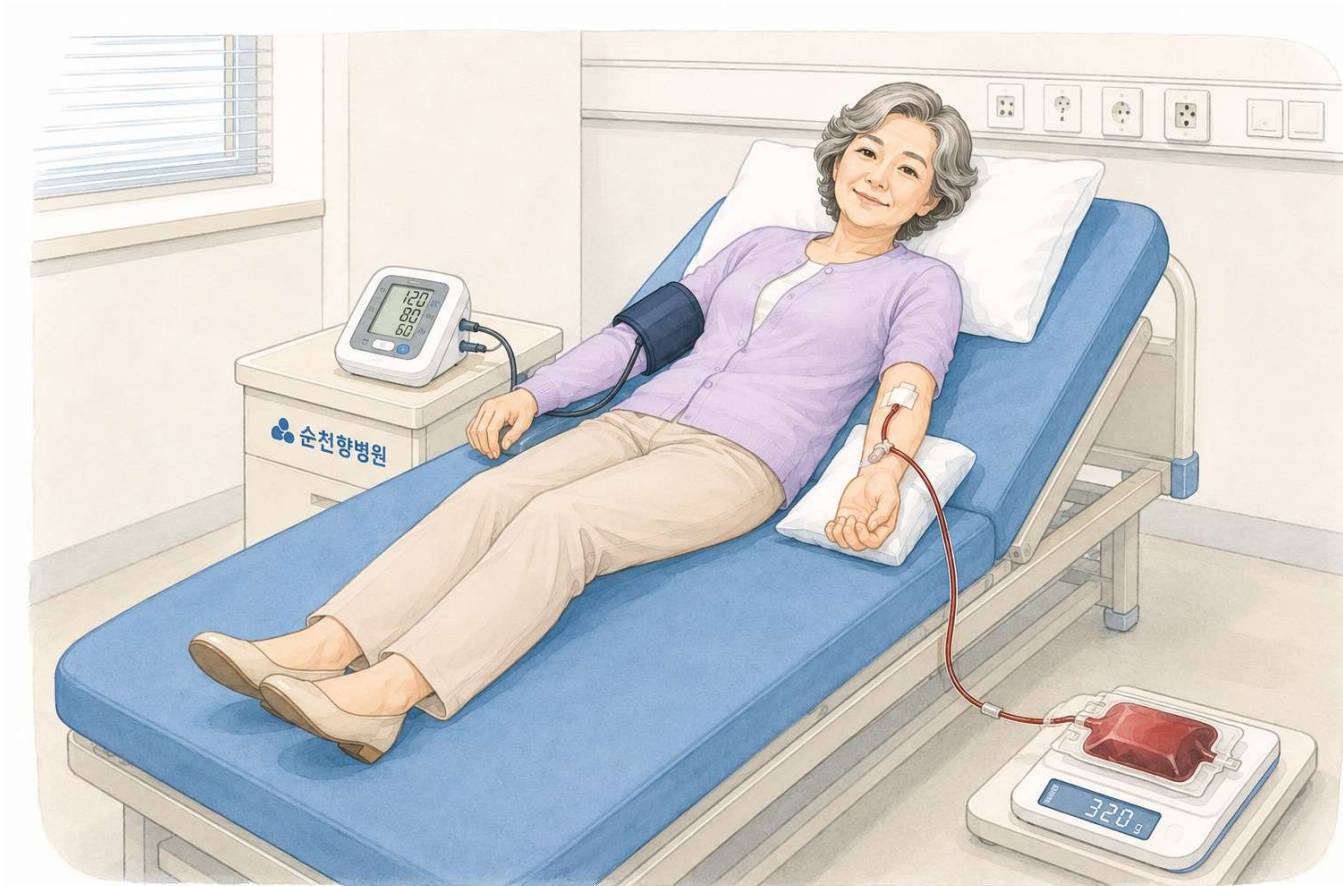
사혈 QI

정맥절개술(사혈술, PHLEBOTOMY)

■ SCHMC · SOONCHUNHYANG UNIVERSITY CHEONAN HOSPITAL



정맥절개술(사혈술, PHLEBOTOMY)



정맥절개술(사혈술, PHLEBOTOMY)

1. 적응증 (Indications)

주로 혈액의 점도가 너무 높거나 체내 철분이 과잉 축적된 경우에 시행

2. 준비사항 (Preparation)

- ① 검사 결과 확인: 시술 직전 혈색소(Hemoglobin) 및 헤마토크릿(Hematocrit) 수치를 확인하여 제거할 혈액량을 결정 -> 교수님 처방 코멘트 확인

12	☒	14	O2040	Phlebotomy
13	☐	15	M0111	Simple Dressing [1일당]
14	☐	16	MTM3102002	네오드레싱 [9CM*10CM]
15	☒	17	ONSPVDSS	Povidone stick swab 0.15g/ea, 2ea/pac
16	☐	18	OHEXICOSS	Hexicohol stikswab soln [Chlorhexidine]
- 300mL				

- ② 수분 섭취: 시술 중 탈수나 혈압 저하를 방지하기 위해 충분한 물을 마시도록 격려
- ③ 식사: 공복 상태에서는 어지러움(미주신경성 실신 등)이 발생할 수 있으므로 가벼운 식사를 권장

정맥절개술(사혈술, PHLEBOTOMY)

3. 시행방법

- ① 앉거나 누운 자세로 시술전 vital sign 측정
- ② 카테터를 삽입할 부위의 피부를 소독 후, 정맥 혈관에 카테터를 삽입
- ③ 카테터를 통해 약 30분~1시간 동안 처방에 따라 300~ 400ml의 혈액을 제거
- ④ 시술후 vital sign 측정, 주의사항 교육
- ⑤ EMR [부서별 기록관리]에서 환자선택 후 서식목록에서 [정맥절개술 간호 기록] 클릭하여 기록
- ⑥ 사혈백 폐기 (입원병동 : 혈액은행 내리기/ 외래 : 주사센터 내 의료폐기물통에 폐기)

정맥절개술(사혈술, PHLEBOTOMY)

4. 주의사항 (Precautions & Side Effects)

■ 시술 중 주의사항

- 1) 미주신경 반응: 어지러움, 식은땀, 메스꺼움, 혈압 저하가 나타나는 지 면밀히 관찰
- 2) 혈관 상태: 대량의 혈액(보통 300~500mL)을 단시간에 뽑아야 하므로 굵은 바늘(18G~20G)을 사용하며, 혈관이 허탈되지 않도록 주의



정맥절개술(사혈술, PHLEBOTOMY)

4. 주의사항 (Precautions & Side Effects)

■ 시술 후 주의사항

- 지혈: 천자 부위를 5~10분 이상 압박하여 멍이나 혈종이 생기지 않도록 함.
- 충분한 휴식 및 당일 활동제한 : 시술 후 피곤함이나 기립성 저혈압이 발생할 수 있는데, 이러한 증상들은 휴식을 취하거나 음료를 마시면 24시간 내에 회복됨.

시술 후 하루 정도는 과격한 육체적 활동은 피하도록 교육

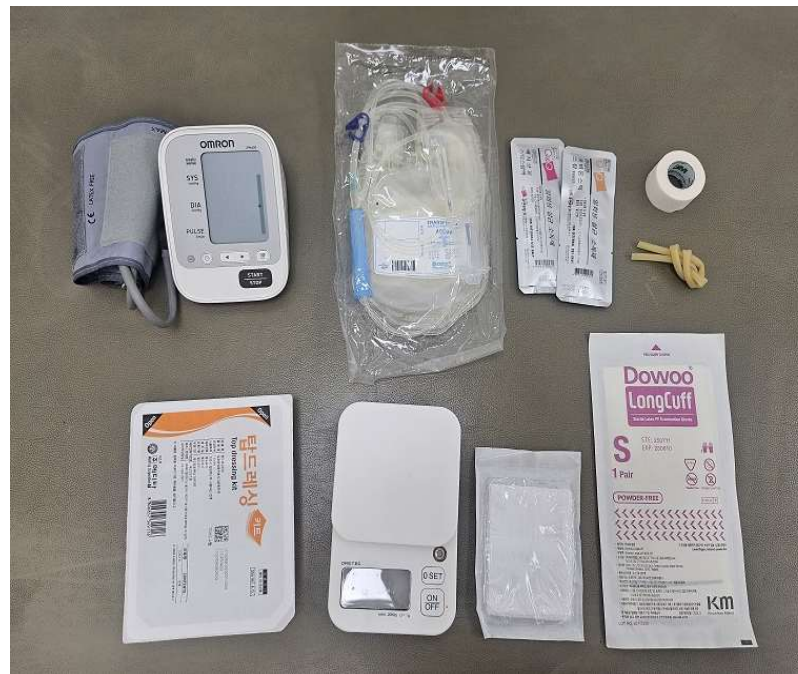
- 지속적 모니터링: 귀가 후 심한 어지러움이나 시술 부위의 지속적인 출혈이 있다면 즉시 의료기관을 방문하도록 교육



정맥절개술(사혈술, PHLEBOTOMY)

5. 준비물품

- 1) D-Set
- 2) 헥시알콜/베타딘 스왑
- 3) 4*4 거즈 or 2*2거즈
- 4) 멸균글러브
- 5) 토니켓
- 6) 저울
- 7) 사혈백
- 8) 혈압계
- 9) 플라스틱



정맥절개술(사혈술, PHLEBOTOMY)

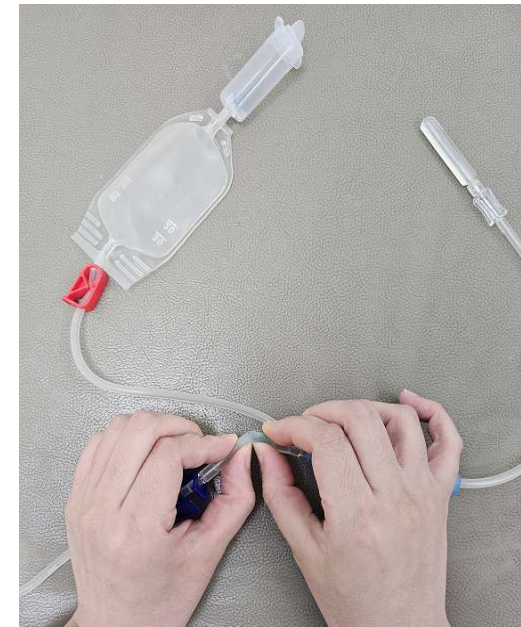
■ 사혈백 준비



drain bag은 하나
(항응고제가 들어있음)
※남은 2개의 bag은 drain 안됨



빨간색 clamp는 잠그기



파란색 clamp는 열어놓고
브레이크 밸브를 꺾어 개통하기

감사합니다